

제 3장 난소의 종양

※ INTRO

- 개념(광의): 모든 종류의 비정상적 난소 부종과 비대
- 발생기전: 신생물, 기능성 낭종, 염증성 종양, 다른 질환에 의해 난소가 침범됨
- 임상증상: 대부분 무증상, 종양 클 경우 복부종괴, 불편감, 통증
- 난소종양의 WHO 분류 -
 - ① 상피성 난소종양(65%)
 - ② 생식세포 종양(20-25%)
 - ③ 성삭기질 종양(6%)
 - ④ 지방세포 종양(0.1%)
 - ⑤ 배아세포 종양(0.1%)

1절 비종양성 난소낭종

1. 개술

- 종양성 낭종과 달리 생리 주기에 따라 발생하고 배란과정과 연관
- 가임기 여성에서 발생
- 대부분 무증상
- 낭종이 파열되어 혈복강을 만들거나 염전으로 심한 골반통을 일으키면 수술 필요

2. 종류

1) 난포낭종

특징	- 가장 흔한 난소의 기능성 낭종으로, 낭 난포의 크기가 3cm를 넘어선 것 - 초경 직후, 폐경기 전후의 여성에게 흔함
원인	- 난포 변화 과정 중의 이상으로 난포가 단순히 과다팽창
임상증상	- 대개 무증상 - 낭종이 큰 경우 발병부위에 무게감, 둔한 동통 - 드물게 하복부 팽창되어 복부비만으로 오인, 골반통 유발
진단	- 촉진, 초음파 검사
치료	- 4~8주 내 저절로 없어지는 경우가 많아 관찰하거나, 경구피임제 복용 - 파열 시 환자의 상태에 따라 안정, 진통제 투여, 수술(낭종 절제) 등 활용

※ 교수님 Tip

- 난포기 ➡ 황체기로 이행하는 단계인 배란기에는 음 → 양으로 전환이 요구됨
- 이때, 전환을 촉진하기 위해 통락활혈 약을 쓸 수 있다
- 추천처방: 축어탕 계열, 도홍사물탕

2) 황체낭종

특징	- 황체의 중심이 정상적으로 낭변화 출혈을 동반하는 과정에서 2cm 이상의 낭종이 형성 - 난포낭종보다 드물게 발생
원인	- 황체형성 시 과다출혈로 인해 혈종 발생 후 혈액흡수되면서 낭성변화

임상	- 무증상
증상	- 둔한 일측성 하복부 동통
진단	- 촉진, 초음파검사, 혈중 hCG검사
치료	- 관찰, 파열 시 낭종절제술

3) 루테인 낭종

= 난포막 황체낭종

특징	- 임신 중 발생, 30cm까지 증대할 수 있음, 양측성 - 가장 적게 발생
원인	- hcG의 과도한 난소자극
임상증상	- 대부분 특별한 증상 X
진단	- 촉진, 초음파 검사
치료	- 관찰 (이상임신이 종결되면 스스로 소멸)

4) 자궁내막증 난소낭종

특징	- 자궁내막증, 초콜릿 낭종이라고도 함
원인	- 자궁내막증에 의해 발생

3. 기능성 난소낭종의 임상 원칙

- 대개 1~3개월 후 자연흡수, 소실 -> 일정기간 반복 진찰하여 종양성 여부 판단

① 크기 8cm 이하, 낭성, 유동성, 가임기 부인 -> 8-12주의 대기요법, 반복 진찰

② ①에서 크기가 증대된 경우 -> 수술요법

③ 폐경 후 여성 -> 발견 즉시 수술

④ 특별한 처치가 없는 기대요법의 대안으로 한방치료 고려

4. 변증치료

- 3개월 관찰기관 이후에도 특별한 증대 소견 없이 잔존 -> 한방치료 일정기간 적용

- 한방치료는 징가, 장담의 범주로 봄

2절 상피성 난소종양 (=종양성 양성 난소종양)

※ 개술

- 종류는 양성 상피성 종양 / 경계성 악성 상피성 종양 / 악성 상피성 종양

1) 역학

- 난소의 상피세포에서 유래된 종양은 전체 난소종양의 67%

- 악성 상피성 종양은 전체 난소암의 90%

2) 특징

- 난소암은 크기가 커지거나 다른 부위로 전이되기 전까지 아무런 증상이 없음

- 처음 진단 받을 때 2/3에서 이미 진행된 상태로 발견, 5년 이상 생존율이 25%

- 다산부, 젊은 초산부, 경구피임제 복용자, 수유모 등의 경우 발생빈도



3) 분류

① 분화경로, 조직학적 유사성에 따라

- 상피성 난소종양의 종양세포는 난관, 내부 자궁경부, 자궁내막, 투명 세포 및 요로상피와 조직학적 유사성 가짐
- > 장액성, 점액성, 자궁내막모양, 투명세포종 및 브레너 종으로 분류

상피성 난소종양의 분화 경로	
장액성	난관
점액성	자궁경부
자궁내막	증식기 내막
투명세포	분비기 내막
브레너	요로상피

② 악성도에 따라

- 악성도에 따라 양성, 경계성 악성, 악성으로 구분

양성	양성. 암 아닌 것.
경계성	세포모양 자체는 좋지 않음, 주변 조직 침습 X
악성	세포모양 좋지 않음, 주변조직 활발히 침습

1. 양성 상피성 종양

- 전체 난소종양의 80-90%는 양성 난소종양
- 대부분 무증상이며 정기검진상 우연히 발견
- 임신횟수, 초경/폐경 나이, 호르몬 제제의 노출정도, 영양상태 등과 관련하여 증가되는 추세
- 호발연령은 40세

증상	- 복부나 골반 내 압박효과로 인한 배뇨문제나 통증 - 생리불순이나 무월경 by 내분비계통 영향 - 체중 및 신체변화
진단	- 악성 종양과의 감별 (혈청 CA-125, 초음파 검사 통해 종

	양 구성성분, 모양 및 혈관 분포 등 확인)
치료	①단순 양성 종양 ★ 폐경전/후 여성 치료 다르게 매우 중요 • 폐경 전 여성: 8cm 미만인 경우 6~8주 간격 초음파 추적 검사 시행 • 폐경 후 여성 1) 5cm 미만인 경우 ➡ 초음파 추적검사 시행 2) 크기 증가, 모양 변화, 복수발생, CA-125 증가할 경우 ➡ 수술적 방법(전자궁절제술, 양측부속기절제술)으로 제거 고려 ②복합/고형성분의 난소종양 •색도플러, CT, MRI 등으로 악성종양과 감별

※ 양성 상피성 종양 치료에서 폐경 전/후 치료 관련

폐경 후 여성에 있어서 양성 상피성 종양 관리기준	
5cm 이하	추적 관찰
5cm 이상으로 크기 증가 모양 변화 or 복수 발생 or CA-125 증가	수술 (전자궁절제술, 양측부속기절제술 등)

1) 장액성 종양

- ① 특징: 상피세포들은 단층의 편평입방상피세포로 구성
: 난관 점막과 흡사한 양상
- ② 빈도: 양성 난소 종양의 25%, 양측성 20%, 양성 50~70%, 경계성 10~15%, 악성 25~35%
- ③ 호발연령: 30~40대 (모든 연령에서 발생 가능)
- ④ 크기: 보통 5~15cm

2) 점액성 종양

- ① 특징: 점액(뮤신)을 분비하는 상피세포로 구성
: 난소종양에서 가장 크게 자라는 종양
- ② 증상: 끈끈한 점액성의 물질 또는 맑은 물질 차있음
: 드물게 점액성 종양으로 인해 장내기관에 점액복수과정 일어나는 복막가점액종이 있음
- ③ 빈도: 20~30%. 양측성 2~10%, 양성 75%
경계성 10%, 악성 15%
- ④ 호발연령: 20~40대
- ⑤ 크기: 평균 15cm, 30~50cm(거대종양)도 있음

3) 자궁내막모양 종양

- ① 개념: 자궁내막세포 모양의 세포가 난소상피에서 종양으로 자라는 것
- ② 빈도: 국내 발병률 1.4%, 80% 이상이 악성
: 양성 난소종양 중 1%미만의 발병률
- ③ 호발연령: 40~50대. 폐경 후 여성에게도 흔함
- ④ 특징: 간혹 자궁내막증에 동반

4) 투명세포종

- 양성 종양과 경계성 종양은 매우 드물, 대부분 암종
- 난소암의 10% 차지. 평균 호발 연령은 61세
- 자궁내막증, 고칼슘혈증과 관련된 가장 흔한

5) Brenner 종양

- ① 특징: 요로상피, 대부분 양성 (경계성, 악성은 드물)
: 장액성 종양이나 점액성 종양과 동반 많이 됨
- ② 빈도: 난소종양의 2%(드물), 악성 비율은 5%이하
: 10~15%에서 양측성
- ③ 호발연령: 40~60대
- ④ 크기: 10cm이상 거의 없음
- ⑤ 증상: 자궁출혈 자주 호소
- 예후 불량

※ 참고 - 양성 상피성 종양의 치료

- 양성 상피성 종양은 종양절제술이 원칙, 단 몇 가지 조건이 고려되어야 함

- ① 임신 원하는 여성: 가능한 보존적 요법 사용, 정상난소조직은 남김
- ② 폐경기 여성: 전자궁절제술 및 양측 부속기 절제술 사용
- ③ 경염전: 색전증 방지 위해 염전을 풀지 않도록 함
- ④ 반대측 난소의 조직검사: 잠재성 종괴 발견 위해 권장 (BUT 육안상 정상으로 보이면 필요 X)
- ⑤ 단순 낭성 종양일 경우: 8cm 미만은 추적검사

2. 경계성 악성 상피성 종양

특성	- 종양의 조직학적 및 생물학적 특징이 명확한 양성과 악성의 중간에 위치 - 조직학적으로 개개 세포는 악성 세포 특성을 보이거나 기질 침윤은 없음
치료	① 수술요법: 원발병소 난소절제술이 원칙

	: 진행된 경우 전자궁절제술 및 양측 부속기 절제술 시행 ② 방사선요법 및 화학요법: 전이가 있을때 사용하나, 효과 불분명
예후	- 광범위한 전이가 있더라도 양호, 5~10년 생존율(↑)

1) 장액성 종양

- 10%가 경계성 종양, 40%가 양측성, 50%가 40세 이전에 발생
- 평균 나이 38세, 50%가 40세 이전에 발생

2) 점액성 종양

- 10%가 경계성, 현미경 상 샘구조 많음
- 대부분 편측성, 평균 나이 45세

3) 자궁내막양 종양

- 전체 경계성 종양의 2~3% 차지

4) 투명세포종

- 경계성 난소 종양의 1% 미만 차지
- 밀집된 섬유성 기질 내에 비정형 샘/낭종들이 투명세포 혹은 징모양 세포로 감싸여 있는 선섬유종과 같은 모양으로, 기질 침윤은 없음

5) Brenner 종양

- 드물게 발생
- 대부분 편측성이며 양호한 예후

3. 악성 상피성 종양 = 상피성 난소암

특성	- 전체 난소암의 90% 이상 차지 - 폐경 후 50~60대에 흔히 발생 (경계성 악성 상피성 종양은 이보다 10년 정도 이른 나이에 발생) - 부인암 중 가장 예후가 나쁜 치명적인 암
원인	- 난소 표면상피가 배란으로 인해 반복적으로 파열되고 복구되는 과정에서 일어나는 자연적 돌연변이 - 배란을 많이 할수록(불임, 빠른 초경, 늦은 폐경 등) 발생 위험 증가
위험 인자	① 유전적 인자: 난소암, 유방암, 자궁내막암, 대장암 가족력 있는 경우 ② 환경적 인자: 유제품, 탄수화물, 주2~4회 계란 섭취 → ↑ 푸른 잎줄기 채소 섭취 → ↓ ③ 생식학적 요소: 미산부, 불임여성 → ↑ 출산, 경구피임약, 모유수유, 자궁절제술 → ↓
진단	- 선별법: 내진, 초음파검사, CA-125로 관찰 - 진단: 시험적 개복술
증상	- 특이적인 증상 X - 종괴에 의한 동통 및 압박증상과 복수, 대장 전이 및 장 전이에 의한 증상
치료	- 다음 내용 참고

1) 장액성 난선암

- ① 특징: 가장 흔함(악성종양의 40~50%), 양측성 (2/3), 경계성 종양과 달리 기질 침윤이 확실함
- ② 호발연령: 50~60대

2) 점액성 낭선암

- ① 특징: 8~10%는 양측성 (대부분 편측성)
: 출혈, 괴사가 흔함
- ② 빈도: 전체 난소암 중 5-10%로 세 번째로 다발
- ③ 호발연령: 53~54세

3) 자궁내막양 암종

- ① 특징: 난소암 중 두 번째로 많음(25%),
: 40%에서 동측 난소 혹은 복막의 자궁내막증이 발견됨
: 15-20%에서 자궁내막암이 동시에 관찰
- ③ 호발연령: 40-50대

4) 종신양 (투명세포) 암종

- ① 특징: 자궁내막증과 고칼슘혈증이 관련된 난소암
: 자궁내막증과 투명세포암의 이행이 자주 발견되며, 투명세포암의 예후는 양호
- ② 빈도: 난소암의 10%, 대부분 편측성
: 50%에서 자궁내막증과 연관

5) Brenner 종양

- ① 발생연령: 평균 55세
- ② 분류: 악성 브레너 종양 / 이행상피암종
- ③ 악성 브레너 종양: 양성/경계성 브레너 종양과 섞여 있는 혼합형 암으로 상당히 드물

6) 진단 및 병력

- ① 선별법: 내진, 초음파 검사, CA-125로 관찰
- ② 증상: 비특이적 / 종괴에 의한 동통 및 압박증상,
복수, 대망 전이 및 장 전이에 의한 증상
- ③ 증세: 골반 및 복부종괴
- ④ 진단: 시험적 개복술
- ⑤ 병기설정: 철저한 수술적 병기 설정이 치료방침 결정

악성 상피성 종양의 치료

1) 병기 설정 (FIGO)

- 철저한 수술적 병기 설정이 치료 방침을 결정

1기	난소에 국한된 종양	
	1a기	일측 난소에 국한된 종양
	1b기	양측 난소에 국한된 종양
	1c기	1a기나 1b기면서 난소표면에 종양 or 피막파열 or 복수 있음 or 복강 내 세척으로 악성세포가 나타날 때
2기	골반내 파괴를 동반한 일측 또는 양측 난소에 국한된 종양	
3기	일측 또는 양측 난소에 종양이 있으면서 골반을 넘어 복강내로 전이하거나 후복막 또는 서혜부 림프절 양성인 경우	
4기	원격전이를 동반한 일측 또는 양측 난소종양	

2) 악성 상피성 난소종양의 서양의학적 치료

1a기	- 전자궁절제술, 양측 부속기절제술, 대망절제술 - 1a기에서 가임능 보전 원하면 자궁, 난소 보전 - 장액성 난소암은 반대측 난소 조직검사 시행
1a기, 1b기	- 자궁절제술, 양측 부속기절제술, 대망절제술

	- 항암약물치료, 방사선치료
2, 3, 4기	- 종양 축소 수술, 항암약물치료, 방사선, 면역치료

3) 치료평가

- 종양표지물질(CA-125), 방사선검사 - CT scan, 2차 추시 개복술

3절 비상피성 난소종양

※ 교과서 개술

- 정의: 조직적으로 이질성을 보이는데 상피성 난소종양을 제외한 종양
- 분류 : ① 생식세포 종양 ② 성삭기질 종양(=성끈간질 종양)이 대부분
(20세 이하 난소종양의 70%가 ① 생식세포 종양)

1. 난소 생식세포 종양

1) 양성 성숙 기형종 또는 유피낭종

특징	- 여성 생식세포종양 중 가장 흔한 종양 (전체종양의 10-20%) - 20세 이하 난소종양 중 가장 흔함 (75% 이상이 20-30대)
임상증상	- 낭종 안은 피지, 머리카락, 피지모낭, 땀분비선, 치아, 연골, 뼈 등으로 채워져 있음 (1-3%에서 악성 변화) - 15%가 양측성
합병증	- 경염전(16%), 낭종파열(0.7%, 응급수술요구)

2) 악성 기형종 또는 미숙 기형종

특징	- 생식세포종양 중 두번째로 흔한 종양 (전체 난소 종양의 1% 이하) - 20세 이하 여성 난소암 중 10~20% (50% 이상이 10-20대)
----	--

3) 미분화 세포종

특징	- 성 생식세포 난소암 중 가장 흔함 (암의 30-40%) - 20세 이하 난소암의 5~10% - 85~90%는 일측성, 10~15%가 양측성
치료	- 수술적 치료 원칙 (임신 원할때는 일회성 자궁 부속기 절제술) - 임신을 원할 때는 자궁 부속기 절제술 시행

4) 내배엽동 종양

특징	- 악성 생식세포 난소암 중 세 번째로 흔함 - 젊은 나이(16-18살)에서 다발, 1/3이 초경 전 - 100% 일측성
치료	- 예후 매우 불량, but 최근 항암 약물 도입으로 향상중

2. 난소 성숙 - 기질종양

- 난소 내 기질은 생식세포를 지지하고 성기삭과 배아 성선의 간질에서 기원하는 세포로 구성
- 전체 난소암의 5~8% 차지
- 저등급의 악성종양으로 예후가 좋으며, 상당수가 40세 이전 진단되고 다양한 스테로이드 호르몬 분비

1) 과립막 세포종

특징	- 가장 흔한 악성 성삭기질 난소종양 - 모든 연령에서 발생할 수 있으나 40~50대 호발 - 일반적으로 일측성이며, 양측성(3%), 난소 밖(10%)
증상	- 골반 또는 복부 동통, 난포 호르몬 분비 종양, 불규칙한 자궁출혈, 조발 사춘기, 폐경기 후 출혈, 자궁내막증식증, 자궁내막암 동반 - 인히빈 수치가 정상보다 7배 정도 상승, AMH 400 평균은 190

2) 난소 섬유종 - 포막종균

특징	- 상피세포나 성선조직을 내포하지 않은 난소의 기질세포에서 유래된 양성 종양 - 모든 연령에서 발생할 수 있으나 50~60대에 호발 - 포막종은 난포호르몬을 분비할 수 있음
증상	- 호르몬 생성되어 비정상적 또는 폐경기 후 자궁출혈
치료	- 원칙적으로 양성이지만 과립막 세포가 혼합된 경우가 있어 난소 절제술을 시행하는 것이 좋음

3) 세르토리 - 라디히 세포종

빈도	- 난소 종양의 0.2%, 환자 평균연령 24-25세
증상	- 종괴가 남성호르몬 분비영향 (77%) - 무월경증, 월경불순 (38%) - 임상적 남성화 (여드름, 다모증, 음핵비대, 목소리굵어짐) (T 수치 증가)
치료	- 임신 원하는 여성에게는 일측성 난소 난관 절제술 (대부분 저악성, 일측성이기 때문)

제 4장 임신성 용모성 질환

※ 교과서 개술

- 정의: 영양배엽이 비정상적 증식을 일으키는 질환
- 분류: ① 포상기태 ② 침윤성기태 ③ 용모상피암 ④ 태반부착부위 용모상피성 종양
- 특징: 임신에서 유래되는 특이한 질환들로, 원격전이되어 말기 상태라도 치료율이 아주 높은 악성 종양 중 하나

※ 용모성 질환의 분류 4가지

포상기태	영양배엽의 증식 및 용모막의 부종을 수반한 비정상 임신에서 기인한 종양
침윤성 기태	영양배엽의 증식이 자궁근층을 깊이 침범하거나 여러 장기에 침범한 것
용모막 암종	태반 부착부 용모성 종양으로, 어떤 경우의 임신 수태 산물에서도 발생할 수 있는 영양배엽의 악성질환
태반부착부위 용모성 종양	용모상피암의 드문 변이형

※ 임신용모막질환의 임상적 분류

양성 임신 용모막 질환	완전 포상기태	
	부분 포상기태	
악성 임신 용모막 질환	비전이성	침윤성 기태 용모막 암종
	전이성	용모막암종 태반부착부위 용모성 종양

상피모양 용모막 종양

1절 포상기태

1. 병리 및 유전학적 특성

- 정의: 영양배엽의 증식 및 용모막의 부종을 수반한 비정상 임신에 기인된 종양
- 특징: 크기가 수mm ~ 1cm이상 에 이르는 포도송이 같은 수포체를 자궁 내에 포함
- 조직 소견 : 팽창된 용모막이 심한 부종으로 수포를 형성한 것처럼 보이며, 자궁내강에 꽉 차있고 일부는 자궁벽에 침윤 소견
- 분류: 아래 표 참고

	완전포상기태	불완전포상기태
증상	전형적인 증상	상대적으로 약함
용모	전체적으로 부음	일부는 정상
모세혈관	태아 적혈구 발견X	태아 적혈구 존재
용모막용모의 과증식	뚜렷	적거나 중등도
태아	양막, 태아 구조물 없음	비정상적인 태아가 존재
재태 연령	8-16주	10-26주
hCG 농도	높음	낮거나 높음
핵형	2배체 46XX가 가장 흔함	3배체
악성화 경향성	15-20%	3-4%

2. 완전 포상기태에 관한 추가설명

- 세포 유전학적 연구에 따르면, 완전포상기태는 순전히 부계의 수태산물의 증식
- 23, X를 가지는 정자와 난자가 수정되나 모체측 핵물질이 없어지고 정자만 배가 됨
- 때때로 2개의 정자가 수정되어 46, XX 또는 46, XY

※ 완전포상기태와 불완전 포상기태의 핵형 차이 짚고 넘어가기

①완전포상기태: [유핵난자 + 정자] OR [무핵난자 + 정자2개]

2배체 48,XX ...

②불완전포상기태: [유핵난자 + 정자2개]

3배체 69,XXY ...

- 이러한 유전적 이상이 세포영양막 또는 융합영양막의 이상증식을 일으킴
- 특징: ① 영양막의 증식 ② 전반적인 용모의 부종 ③ 배아, 태아 조직 없음

※ 완전 포상기태의 현미경적 소견

- ① 팽창된 용모막의 심한 부종
- ② 용모간질 혈관 등의 소실
- ③ 용모막을 싸고 있는 영양배엽의 과다증식
- ④ 태아의 소실

3. 포상기태의 발병 위험 인자

- 연령: 15세 미만 20배 / 20~35세 1배 / 40세 이상 2-10배 / 50세

이상 80배

- 반복성 포상기태 (20~40배)
- 산과력: 자연유산 횟수가 많을수록 증가
- 다태임신
- 유전인자: 균형 전좌 (balanced translocation) 인 경우 약간 증가
- 음식: 단백질 결핍
- 동양인

4. 임상증상 및 증후

자궁출혈	- 90% 이상으로 가장 흔함 - 기태임신 4주 정도에서 적자색 출혈로 시작 - 혈괴와 함께 기태성 수포체가 동시에 유산되기도 함
빈혈	- 헤모글로빈 10g/dl 이하로 떨어짐 [54%] - 수혈이 필요한 환자는 10% 이하
자궁크기 증대	- 자궁크기가 임신 주수에 비해 큰 경우 [50% 이상]
자간전증	- 임신 20주 이전에 고혈압, 단백뇨가 발생하는 증상 - 임신 초기의 자간전증은 포상기태
임신구토증	- 극심한 임신 구토증은 다태임신 및 포상기태에서 20~26% 정도 나타남
갑상선 기능 항진증	- 고열, 빈맥, 따뜻한 피부 등
용모세포 전색증	- 흉통, 호흡곤란, 빠른호흡, 심계호흡 등
난포막황체낭	- 난포막 황체의 크기 > 6cm - 낭종 발견, 기태 제거 후 hCG 소멸 이후 2~4개월 후 자연소멸

※ 포상기태의 증상발현

완전포상기태
질출혈(97%), 거대자궁, 자간전증(27%), 임신과다구토(26%)
갑상선기능항진증(7%), 영양배엽색전증(2%), 포막황체낭종(50%)
부분포상기태
특징적인 임상증상 無
불완전 유산 or 계류 유산의 증상
67%에서 재태 연령보다 자궁의 크기가 작음

5. 진단과 감별진단

- 임상증상 + 초음파 소견 + 생화학적 검사(hCG) 종합활용
- 다음과 감별
 - 다태임신, 절박유산, 불완전 유산, 자궁외임신, 계류유산
 - 자궁근종, 난소낭종을 동반한 임신 등

6. 치료 및 임상적 관리

- 포상기태의 관리는 크게 나누어서
- 포상기태 제거 후 적절한 추적검사만 하는 경우
- or
- 예방 목적으로 항암화학 요법을 추적검사와 병행하는 것
- ※ 유의점
 - 포상기태의 임상적 위험도 / 출혈, 구토증 / 임신 중독증 / 폐전색증
 - 혈액응고 기전의 장애

① 포상기태 제거 전의 검사 시행: hCG 검사, 갑상선 기능검사 ...

② 예후 인자 검사: 자궁의 크기, 기태 제거 전 hCG 값(≥ 10 만 mlU/ml 일 경우 예후 안 좋음), 기태 조직의 폐 전이

③ 기태 제거: 흡입 소파술, 개대 소파술, 자궁절개술, 자궁절제술, 약제 처치법

④ 추적 검사: hCG 측정, 흉부 X-선 촬영, 피임(12개월)

⑤ 경쾌 판정: B-hCG 값이 연속 3회 이상 음성(1.5~5mlU/ml)일 경우 경쾌 판정

⑥ 치료 적응증(화학요법) 확인: 조직 소견상 용모상피암의 진단, 전이 병소의 발견, 기태 제거 후 B-hCG 상승하거나/감소없거나/재상승

⑦ 예방적 화학 요법 : 고위험군 포상기태에 대해 actinomycin-D 사용

⑧ 자연사 : 기태 제거 후 80% 자연 경쾌

12~15% 침윤성 기태

5~8% 용모상피암으로 진행

2절 임신성 용모성 종양

※ 교과서 개술

- 정의: 포상기태 후 과다한 영양배엽의 증식으로 자궁근층을 깊이 침범하거나, 여러 장기에 전이를 일으킨 경우
- 분류: ① 침윤성기태 ② 용모상피암 ③ 태반 부착부 용모성 종양

1. 임신성 용모암 유발 선행인자

- 포상기태(50%), 유산(25%), 정상 분만(22.5%), 자궁외 임신(2.5%)

2. 임신성 용모성 종양의 자연사

1) 비전이성 질환

- 포상기태 임신 약 15%에서 국소적 침윤성 용모성 종양이 속발
- 부정기적인 질 출혈, hCG의 증가
- 종양세포가 자궁근층을 천공시켜 복강 내 출혈을 일으키거나 자궁 혈관을 침투하여 질 출혈 야기

2) 전이성 질환

- 포상기태 제거 후 약 4%, 다른 선행 임신 후에는 흔하지 않음
- 보통 용모상피암(조기에 혈관 침투하여 광범위한 전이)과 관련

임신 용모성 종양의 전이 장소 및 전이율

폐	80%	간	10%
질	30%	장, 신장	5%
골반	20%	비장	5%
뇌	10%	기타	5%

- 폐 전이 시 증상: 흉통, 기침, 객혈, 호흡곤란 유발
- 질 전이 시 증상: 생검 시 과다출혈

3. 치료 전 평가 및 임상 분류

1) 임상병기 분류 및 치료 전 검사에 포함되어야 할 항목

- ① 선행 임신의 종류와 기간
- ② 조직 병리 소견
- ③ 장기전이 유무
- ④ 기초 hCG 값
- ⑤ 화학요법 중의 약제 독성 정보를 위한 조혈기능, 간기능, 신기능 및 내과적 검사

2) 용모성 종양의 사인

- ① 종양성 : 출혈(자궁근종, 뇌졸중, 간출혈, 폐출혈, 위장관 출혈)
: 뇌부종, 혈관내 응고
- ② 항암제 합병증
- ③ 수술 후 합병증

3) 임신성 용모성 종양의 임상적 분류

① 병기 분류법

1기	지속적인 hCG 상승과 종양이 자궁에 국한된 경우
2기	종양이 질, 골반에 전이
3기	자궁·질·골반에 종양 존재 유무 관계 없이 폐 전이
4기	뇌·간·신장·위장관 전이(원격 전이) 또는 기타 장소 전이

② FIGO 2000 scoring에 의한 점수분류 (예후 점수제 분류)

예후인자	0	1	2	4
나이	≤ 39	> 39		
선행임신 형태	포상기태	유산	만삭출산	
지난 임신과의 시간 간격	<4개월	4~ 7개월	7~ 13개월	>12개월
혈중 hcG 값(mlU/ml)	<10 ³	10 ³ ~ 10 ⁴	10 ⁴ ~10 ⁵	≥ 10 ⁵
가장 큰 종양크기(cm)	<3	3~5	>5	
전이장소	폐	비장, 신장	위장관, 간장	뇌
확인된 전이 종양의 숫자		1~4	5~8	>8
선행			단일약물	복합약물

항암요법에 대한 반응				
----------------	--	--	--	--

- 점수가 7 이상일 때 고위험군, 7 이하가 저위험군
- 점수에 따른 저/중/고위험군 구분에는 자료마다 차이 존재

4. 처치

- 최근 항암제 개발과 적절한 약물의 선택으로 임신 용모성 종양은 대부분 항암제만으로 치료될 수 있는 질환
- 주된 치료방법: 적절한 화학요법 수술은 보조적 방법

1) 화학요법

- 최소한의 독성으로 최대한의 치료효과를 나타내는 화학요법
- 비전이성 종양 OR 저위험 전이 종양 ➡ MTX or ACT-D 이용한 단독요법
- 고위험 환자 ➡ MAC or EMA or EMACO 등 병용 요법

2) 보조적 수술 (보조적 자궁적출술)

- 용모상피 종양에서 단순히 수술적 처치만 하는 것은 항암화학요법 치료가 시행되기 전 과거의 치료방법
- 화학요법치료가 장기간 소요되는 경우, 빠른 시행을 위해 시행
- 보조적 수술만 하고 종료가 아니라, 빠른 시행을 위해 먼저 보조적 수술하고 그 후 완전치료를 위해 화학요법치료로 마무리하는 것
- 화학요법 치료 중 빠른 치유를 위해 보조적 수술을 시행하고, 수술 후 완전 치유에 이를 때까지 화학요법 치료를 계속함

※ 용모상피암 환자의 자궁절제술 적응증

- ① 대량의 자궁출혈이 있는 경우
- ② 조절되지 않는 자궁감염
- ③ 자궁강에 국한해서 나이가 많은 사람(>35), 임신을 원하지 않는 환자
- ④ 화학요법 이후 심각한 독성으로 삶의 위협을 받는 경우
- ⑤ 태반 부착부 용모성 종양

3) 방사선 치료

- 효과적이지 못함
- 출혈을 방지하기 위해, 뇌 전이된 경우 뇌 방사선 치료 시행

4) 병기에 따른 치료법

5. 결과

- [과거] stage1, 2, 3(병기 1~3) 모두 100%, stage 4는 45% 회복
- [최근] stage 4에 대한 치료법의 발달로 75% 회복

6. 추적관리

- 경쾌 판정: 혈청 β -hCG 값이 연속 3주 이상 음성(1.5~5mIU/ml)인 경우

stage 3	경쾌 판정 후 매월 1회씩 1년간 hCG 측정
stage 4	경쾌 판정 후 매월 1회씩 2년간 hCG 측정

- 매 3개월마다 내진 및 임상 검사, 그 후 5년까지는 6개월마다, 5년 이후는 매년
- 첫 1년간 피임 요망 (stage4는 2년동안)

7. 다음 임신

- 후속 임신에서 특이할 만한 선천성 기형, 산전 혹은 산중 합병증의 빈도 증가 X
- 포상기태 임신 후 다음 임신에서 다시 포상기태 임신 올 가능성은 약간 증가

※ 활용할 수 있는 처방 (교과서 外 추가설명)

- 삼석모탕
- 오령홍화탕